

控制膀胱最有效的两种初始方法，不需要药物或手术：**盆底肌锻炼**（常称凯格尔运动）可增强支撑尿液的肌肉力量；**膀胱训练**则帮助膀胱逐渐延长两次如厕之间的间隔。坚持练习可改善压力性漏尿、尿急和尿频，且安全无费用。

作用原理

- **盆底肌锻炼**增强膀胱和尿道下方的肌肉支撑，减少咳嗽、提重物或运动时的漏尿，并有助于抑制尿急。
- **膀胱训练**逐步延长如厕间隔，平息膀胱过度活动症，减少尿频。

找到正确的肌肉

盆底肌是您用来**中断尿流**或憋住排气时所用的肌肉。收缩并上提这些肌肉，**不要**收紧腹部、臀部或大腿，**也不要屏住呼吸**。（不要真正在排尿时中断尿流来练习——那只是定位肌肉的方式。）若无法找到这些肌肉，**盆底物理治疗师**可以提供帮助，有时借助生物反馈技术。

名词解释

盆底

支撑膀胱、肠道及（女性）子宫的肌肉群。

凯格尔运动（Kegels）

针对盆底肌的收缩上提练习。

膀胱训练

逐步延长两次如厕之间的时间。

抑制尿急

在突发尿意时平息冲动，避免漏尿后再走向厕所。

生物反馈（biofeedback）

一种帮助确认是否使用正确肌肉的工具。

盆底物理治疗师

专门针对盆底肌的康复治疗师。

多久才能见效？ 需要耐心——大多数人在坚持练习约**6–12周**后开始感到改善，且随着坚持会持续进步。如同其他锻炼，一旦停止效果会减退，因此目标是将其养成长期的日常习惯。

简单的每日练习

- 1 **收缩**盆底肌，保持3–5秒，然后充分**放松**同等时间。
- 2 每组重复约**10次**，每天做**3组**。随力量增强逐渐延长保持时间。
- 3 加入几次**快速有力的收缩**，在咳嗽、打喷嚏或提重物前使用（称为“技巧收缩”）。
- 4 每次收缩之间充分放松，与收缩同样重要。

膀胱训练

- 记录简短的**膀胱日记**，了解自身规律。
- 当尿意来袭时，**停下来、收缩盆底肌、深呼吸**，待尿意减退后再平静走向厕所。
- 以每次延长15分钟的步骤，逐渐将如厕间隔延长至每3–4小时一次。

实用提示

- 这些练习可以**随时随地**进行，旁人不会察觉。
- 坚持比强度更重要；将练习与日常习惯关联（如餐时、等红灯时）。
- 若有**盆腔疼痛**或盆底肌过度紧张，目标可能是**放松**而非增强——请咨询您的医疗团队。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- 无法判断是否使用了正确的肌肉
- 锻炼后疼痛**加重**或出现压迫感
- 练习数月后无明显改善

需要记住的三件事

1. 盆底肌锻炼与膀胱训练安全、免费，是改善漏尿、尿急和尿频的有效初始方法。
2. 收缩正确的肌肉（不要屏气），每次收缩后充分放松，并逐步训练膀胱延长等待时间。
3. 坚持6–12周并保持习惯。若疼痛加重或无法找到肌肉，可咨询盆底物理治疗。